Nome do Documento:	**PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO PARA ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO DE ONCOLOGIAT NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI**		
Data da Emissão:	22/11/2024	**Tipo de Documento:**	Procedimento Operacional
Emitido Por:	Fernanda Lasmar Thais dos Passos Freitas	**Revisado Por:**	Thereza Christina Griep
Aprovado Por:	Thereza Christina Griep	**Nº Revisão:**	Emissão Inicial

1. INTRODUÇÃO

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, com mais de 10 milhões de óbitos a cada ano. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 704 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados por ano entre 2023 e 2025, em comparação a 625 mil novos casos da doença no triênio anterior. Isso significa que 237 mil casos a mais devem surgir nos próximos três anos, uma média de 79 mil novos casos a mais por ano.

Em face dos fatos acima, os serviços de saúde enfrentam um aumento da demanda por atendimentos na especialidade, o que impõe o estabelecimento de um serviço eficaz de Regulação da Assistência à Saúde.

A regulação em Oncologia pelo SUS busca organizar o acesso aos serviços habilitados, priorizando consultas médicas, procedimentos diagnósticos e terapêuticos aos pacientes com maior risco, necessidade e/ou indicação clínica, provenientes dos diversos pontos de atenção. Logo, a Secretaria de Saúde do Município de Araguari buscou a criação deste protocolo, sendo obrigatórias a descrição de todas as informações solicitadas.

2. OBJETIVOS

Este protocolo tem como objetivo organizar e padronizar o processo de solicitação e encaminhamento dos casos suspeitos ou diagnosticados em oncologia, intuindo a celeridade para o início do tratamento.

3. FLUXOGRAMA DE ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTAS EM ONCOLOGIA

Usuários com diagnóstico confirmado de câncer ou considerados com alta suspeição atendidos nos serviços de saúde da macrorregião de Araguari serão encaminhados via solicitação TFD para inserção na fila de espera da Comissão Municipal em Oncologia do município de Uberlândia.

ATENÇÃO: O paciente deverá ser encaminhado EXCLUSIVAMENTE para este setor, não devendo ser encaminhado para nenhuma outra especialidade.

Buscando priorizar o acesso às consultas e exames pertinentes a detecção precoce e estadiamento clínico, é imprescindível que todas as informações consideradas relevantes ao caso estejam descritas na solicitação.

Cabe ressaltar que esta via de marcação se refere exclusivamente ao atendimento eletivo e ambulatorial para pacientes em condições clínicas para tal e que não necessitam de internação imediata. Solicitações de avaliações para urgências devem obedecer aos fluxos específicos já estabelecidos.

Posto isso, segue os passos para ABERTURA DE PASTA-PACIENTES NOVOS ONCOLOGIA:

a) Paciente é atendido por médico que confirma o diagnóstico de câncer ou alta suspeição.

b) Médico assistente preenche relatório detalhado e o TFD (Tratamento Fora de Domicílio), via única, assinada e carimbada, com letra legível e histórico clínico detalhado do paciente;

c) O paciente reúne a documentação exigida e procura o Núcleo de Acolhimento Psicossocial (sala 4) da Secretaria de Saúde de Araguari, responsável por

acolher o usuário e seus familiares, orientar e verificar se a documentação está dentro dos critérios estabelecidos no Protocolo de Oncologia. Em caso de não conformidade, o processo é devolvido para a origem, com as devidas considerações;

d) O responsável pela pasta de Oncologia da Central de Regulação insere o paciente no Sistema Fast Medic na fila: MUNICÍPIOS PACTUADOS – COMISSÃO MUNICIPAL DE ONCOLOGIA contendo os anexos: xerox dos documentos pessoais, comprovante de endereço, TFD, relatório médico com história clínica detalhada, exames complementares (anatomopatológico, ressonância, tomografia, endoscopia, colonoscopia, entre outros);

e) Após a inserção, a documentação passará por análise, conferência e regulação através Central de Regulação de Uberlândia, e será agendado através da confirmação realizada pelo próprio município no Sistema Fast Medic.

f) O administrativo responsável pela Pasta de Oncologia da Central de Regulação entra em contato telefônico com o paciente para comunicar ao paciente que sua autorização de consulta na Oncologia está liberada, informando o dia, horário e local do agendamento.

g) O paciente comparece à Sala 4 da Secretaria de Saúde de Araguari para retirada da Autorização de agendamento;

h) O paciente comparece à consulta no dia, horário de local agendados portando sua documentação pessoal bem como relatórios e exames médicos.

OBSERVAÇÃO: Em caso de não comparecimento JUSTIFICADO à consulta na Oncologia em Uberlândia, o paciente deverá procurar a sala de acolhimento psicossocial (sala 4) da Secretaria de Saúde de Araguari e preencher uma ficha de acolhimento solicitando um novo agendamento.

4. PROFISSIONAL REQUISITANTE HABILITADO

As solicitações podem ser feitas pelo profissional médico assistente, após avaliação e enquadre aos critérios estabelecidos pelo Protocolo Clínico de Alta Suspeição em Oncologia do Estado de Minas Gerais. Serão inseridos no fluxo estabelecidos os pacientes advindos da rede SUS bem como também aqueles advindos de atendimento na rede particular e convênios, caso optem por tratamento via Sistema Único de Saúde.

5. INDICAÇÕES PARA O ENCAMINHAMENTO

Poderão ser encaminhados para avaliação da Comissão de Oncologia do município de Uberlândia os pacientes com:

*diagnóstico de câncer confirmado;

*critérios de alta suspeição para câncer cujas normativas estão descritas a seguir.

5.1 Confirmação diagnóstico oncológico

A confirmação do diagnóstico oncológico poderá ser feita por meio de:

a) Exame anatomopatológico obtido por biópsia ou procedimento cirúrgico;

b) Exames de imagem e laboratoriais para casos específicos de tumor com alta suspeição clínica (Protocolo Alta Suspeição);

c) Exame físico e história clínica altamente sugestiva de neoplasia.

5.2 Critérios de encaminhamento Alta Suspeição

Em 20 de março de 2019 através da Deliberação CIB-SUS/MG Número 2909 houve a aprovação do Protocolo Clínico de Alta Suspeição em Oncologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de Minas Gerais.

O objetivo é promover o encaminhamento dos usuários de Alta Suspeição Oncológica para confirmação diagnóstica de câncer nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou nos Centros de Assistência Especializada em Oncologia (CACON).

O objetivo é reduzir é reduzir a tempo de espera para o início do tratamento oncológico entre o diagnóstico e o início do tratamento, melhorando consequentemente o prognóstico da doença.

O profissional deverá seguir o Protocolo nos casos de alguns tipos específicos de tumor com Alta Suspeição. Serão contempladas neste Protocolo os seguintes critérios em cada especialidade:

5.2.1 ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

A) Sangramentos inexplicados, epistaxe e/ou petéquias, hematomas, palidez palmar ou conjuntival grave (VER TAMBÉM HEMATOLOGIA);

B) Dor óssea localizada e contínua, com ou sem aumento de partes moles, com duração maior que 15 dias;

C) Cefaleia associada a vômitos matinais e alteração do exame neurológico, excluídas as causas oftalmológicas e sinusopatias;

D) Adenomegalias maior que 2,5cm, de qualquer localização;

E) Febre de origem indeterminada com duração maior que 15 dias, excluídas causas infecciosas;

F) Massa abdominal palpável, com ou sem hematúria, sem história de trauma ou de hipertensão arterial;

G) Alargamento de mediastino comprovado à radiografia de tórax, excetuando-se as hiperplasia tímicas;

H) Alteração dos olhos: brilho, reflexo branco (leucocoria), proptose, heterocromia, equimose bilateral;

5.2.2 NEUROLOGIA

Tumor primário do SNC: Massa sugestiva de neoplasia maligna identificada por método de imagem (Tomografia Computadorizada ou Ressonância de Crânio);

5.2.3 ORTOPEDIA E COLUNA

a) Tumor ósseo ou de partes moles: Lesão sugestiva de neoplasia maligna por métodos de imagem;

b) Coluna: Imagem compatível com tumor de coluna vertebral invadindo o canal raquimedular ou tumor primário intra-espinal.

5.2.4 MASTOLOGIA

a) Mamografia com BI-RADS 04 E 05;

b) BI-RADS Ressonância Magnética (RNM) 05;

c) BI-RADS Ultrassonografia (USG) 05;

d) PAAF com citologia sugestiva de neoplasia maligna;

e) Exame físico com lesão mamária altamente sugestivo de malignidade (lesão ulcerada, nódulo de consistência endurecida, aderido, com retrações);

5.2.5 GINECOLOGIA

a) Biópsia com NIC (Neoplasia Intra-epitelial Cervical) II ou III;

b) Biópsia com NIVA (Neoplasia Intra-epitelial Vaginal) II ou III;

c) Biópsia com NIV (Neoplasia Intra-epitelial Vulvar) II ou III;

d) Colpocitologia oncótica sugestiva de invasão ou microinvasão;

e) Colo Uterino: lesão ulcerada ao exame especular sugestiva de neoplasia maligna;

f) Vulva: Lesões ulceradas vegetantes na vulva;

g) Endométrio: Sangramento pós-menopausa com espessamento endometrial à ultrassonografia;

h) Ovário: Massa ovariana complexa sugestiva de neoplasia maligna por método de imagem;

5.2.6 TÓRAX

- Tomografia Computadorizada de Tórax (Laudo) com:
- Nódulo pulmonar solitário não calcificado MAIOR que 01cm sugestivo de neoplasia maligna;
- Lesão pulmonar solitária sugestiva de neoplasia maligna;
- Lesão ÚNICA em mediastino sugestiva de neoplasia maligna;
- Lesão ÚNICA em parede torácica (costelas, esterno e partes moles) excetuando-se as lesões de mama, sugestiva de neoplasia maligna;
- Imagem compatível com lesões metastáticas;
- Obrigatória exclusão de Tuberculose Pulmonar (BAAR negativo);

5.2.7 APARELHO DIGESTIVO

A) Esôfago

- Disfagia (Dificuldade para engolir) de início recente e/ou progressivo, sensação de refluxo (azia) por mais de duas semanas + Perda de 10% de peso inexplicada em pacientes com mais de 55 anos com um ou mais dos seguintes sinais:
- Dor abdominal;
- Azia de início recente;
- Dispepsia;
- Náusea/vômito.

B) Estômago

- Massa abdominal palpável OU;

Em pacientes > 55 anos com perda de 10% do peso de forma inexplicável com um ou mais dos seguintes itens:

- Dor abdominal superior;
- Dispepsia (dificuldade de digestão);

- Náusea e vômito;
- Hematêmese (vômito com sangue) /melena (sangue nas fezes “borra de café”);
- Azia (queimação no estômago) de início recente;
- Sensação de refluxo (azia) por mais de duas semanas.

C) Pâncreas

- Massa pancreática sólida ou heterogênea sugestiva de Neoplasia Maligna por métodos de imagem
- Imagem de dilatação de ducto pancreático sem fator obstrutivo identificado;
- Icterícia obstrutiva, excluindo coledocolitíase;
- Inexplicável perda de 10% do peso com um ou mais dos sintomas abaixo:
- Diabetes recente
- Desconforto recente em região abdominal (dorso)
- Esteatorreia
- Náusea/vômitos

D) Fígado

- Massa Hepática Sólida ou Heterogênea sugestiva de Neoplasia Maligna por métodos de imagem;
- Perda de 10% do peso inexplicável
- Icterícia obstrutiva

E) Vesícula e Vias Biliares

- Massa abdominal consistente com um tumor da vesícula biliar;
- Icterícia obstrutiva indolor, excluída coledocolitíase;

F) Cólon/Intestino

- Câncer de intestino conhecido ou suspeito (em exames de imagem, ou palpável ou visível no exame retal);

- Sangramento retal inexplicável (excluídas causas anais benignas como hemorroidas);

50 anos ou mais com: anemia ferropriva ou mudanças no hábito intestinal ou testes de sangue oculto monoclonal nas fezes positivo.

5.2.8 UROLOGIA

A) Próstata: PSA total maior que 10ng/ml (Pacientes com PSA acima de 4ng/dl e/ou com toque alterado e/ou história clínica têm indicação de avaliação na atenção especializada);

B) Testículos: Massa testicular sólida confirmada por métodos de imagem ou presença de nódulo testicular associado ao aumento dos marcadores Alfa-Fetoproteína (acima de 15ng/ml) ou Beta-HCG (acima de 2,6mUI/ml);

C) Rim: Massa renal sólida ou heterogênea por métodos de imagem (Bosniak III ou IV);

D) Bexiga: Lesão sugestiva de neoplasia maligna por métodos de imagem.

5.2.9 SARCOMA

Uma massa de tecido mole inexplicada com um ou mais dos seguintes sinais:

- Tamanho da massa >5cm com crescimento;
- Profundo à fáscia;
- Doloroso;
- Radiologia suspeita de malignidade;
- Uma recorrência após excisão prévia.

5.2.10 CABEÇA E PESCOÇO

Lesões (placas ou manchas) ou ulcerações ou edema na mucosa oral que persistam por mais de três semanas, em qualquer localização, particularmente se indolores;

Dor ou desconforto persistente na garganta, particularmente se unilateral ou há mais de quatro semanas;

Linfadenomegalia cervical que persista por mais de três semanas;

Secreção nasal serosanguinolenta unilateral que persista por mais de 3 semanas;

Paralisia facial, hipoestesia ou dor facial grave;

Tumorações orbitais ou otalgia sem evidências de anormalidades ao exame físico e otoscopia.

5.2.11 HEMATOLOGIA

a) Linfomas

Linfonodomegalias persistente por 4 semanas ou mais;

Linfonodomegalia de crescimento rápido sem uma causa óbvia aparente;

Linfonodomegalia intrabdominal em exames de imagem;

Massa mediastinal em exames de imagem.

b) Leucemias

Leucocitose (qualquer nível) com presença de BLASTOS no hemograma (geralmente associada à anemia e/ou plaquetopenia);*

Leucocitose > 100.000/mm3 com ou sem BLASTOS, mas com desvio escalonado para esquerda com ou sem anemia e/ou plaquetopenia;

Pancitopenia (anemia, plaquetopenia < 100.000/mm4, leucopenia com neutropenia grave <1000/mm3).

**esses casos configuram uma urgência clínica.

c) Mieloma Múltiplo

Eletroforese de proteínas séricas ou urinárias com pico monoclonal e UM ou MAIS dos fatores abaixo:

Anemia inexplicada;

Insuficiência renal (elevação de creatinina > 2,0mg/dl) inexplicada;

Hipercalcemia (cálcio);

Lesões ósseas osteolíticas em exames de imagem.

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE ONCOLOGIA

- TFD preenchido com letra legível e histórico detalhado do paciente, devidamente assinado e carimbado pelo médico assistente;
- Relatório médico com justificativa detalhada e direcionado ao Serviço de Oncologia;
- Exames complementares (laudo biópsia, ressonância, tomografia). Somente laudos, não são necessárias as imagens dos exames;
- Xerox dos documentos pessoais (RG, CPF, Cartão SUS, certidão civil (nascimento, casamento);
- Comprovante de endereço: preferencialmente conta de energia (CEMIG).
- Telefone de Contato: no mínimo 2.

7. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Pacientes com critérios para alta suspeição ou com diagnóstico confirmado, serão classificados como prioridade vermelha.

8. CRITÉRIOS DE NÃO CONFORMIDADE

Ausência de exames complementares (biópsia, ressonância, tomografia...);

Formulário preenchido de forma incompleta, incorreta ou ilegível;

Indicação não contemplada nas diretrizes do protocolo.

9. ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS, RESPONSABILIDADES DE CADA ESFERA

9.1- Compete às Unidades Solicitantes

Orientar o paciente quanto ao fluxo de Oncologia da rede;

Preencher o TFD em 1 (uma) via, com assinatura e carimbo médico;

Fornece relatório médico detalhando o histórico clínico do paciente;

Com os passos acima cumpridos, o paciente pode procurar o Núcleo de Acolhimento Psicossocial da Secretaria de Saúde (sala 4) com a documentação completa para dar entrada à solicitação da consulta no Serviço de Oncologia.

9.2- Compete ao Profissional da Central de Regulação-Pasta Oncologia

Conferir a adequação de toda a documentação descrita acima;

Cadastrar o paciente na fila do Fast Medic Comissão Municipal de Oncologia do Município de Uberlândia;

Contatar o usuário após a liberação de vaga pela Comissão Municipal de Oncologia (prazo habitual de 60 dias) para que retorne à Central de Regulação-Pasta de Oncologia para a retirada da autorização da consulta especializada;

Avaliar regularmente a fila de devolução da solicitação no sistema Fast Medic pois por ausência de algum documento o agendamento pode não ser realizado.

9.3 Compete ao Usuário

Providenciar a documentação descrita anteriormente;

Manter atualizado seu cadastro na rede municipal de saúde;

Comparecer ao Núcleo de Acolhimento Psicossocial (sala 4) portando toda a documentação descrita acima;

Após contato telefônico do profissional da Central de Regulação comparecer ao setor para retirada do comprovante de agendamento;

Comparecer à recepção da unidade executante (Hospital do Câncer de Uberlândia) no dia e horário descritos no agendamento;

Levar no dia da consulta o comprovante de agendamento contendo data e horário;

Levar documentação pessoal para a realização da consulta (RG, CPF e cartão SUS);

Levar exames anteriores no dia da consulta na Oncologia e relatório médico.

10. REFERÊNCIAS

CIB-SUS No 2.909 (Protocolo de Alta Suspeição): Aprova o Protocolo Clínico de Alta Suspeição em Oncologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de Minas Gerais.

Lei 12.732/2012 (Lei dos 60 dias): Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início.

Lei 13.896/2019 (Lei dos 30 dias): Altera a Lei no 12.732, de 22 de novembro de 2012, para que os exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna sejam realizados no prazo de 30 (trinta) dias, no caso em que especifica.

Nome e Função	Assinatura
Thereza Christina Griep **Secretária Municipal de Saúde**	THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024 Assinado de forma digital por THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024 Dados: 2026.05.13 11:36:45 -03'00'
Fernanda Lasmar **Médica rreguladora**	gov.br Documento assinado digitalmente FERNANDA BASSO LASMAR ROCHA Data: 14/05/2026 08:00:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Thais dos Passos Freitas **Psicóloga**	gov.br Documento assinado digitalmente THAIS DOS PASSOS FREITAS Data: 19/05/2026 09:43:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br